

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE HUMOR (HSQ-24)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de los Estilos Adaptativos y Desadaptativos de Humor

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Estilos de Humor (HSQ-24: 24 reactivos).
Nombre Original (Inglés)	<i>Humor Styles Questionnaire (HSQ)</i>
Autores Originales	Drs. Rod A. Martin, P. Puhlik-Doris, G. Larsen, J. Gray y K. Weir (2003).
Validaciones Españolas	Begoña Carbelo, M. A. Ruiz & R. Rodríguez-Carvajal (2006); Torres-Marín et al. (2022).
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Regulación Afectiva, Comunicación Interpersonal y Coping.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico de 24 reactivos distribuidos en 4 dimensiones de 6 ítems (Likert 1 a 6).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Población comunitaria y clínica ambulatoria.
Tiempo de Administración	4 a 6 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docente y de investigación bajo citación formal.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO CUADRIPOlar DE ROD MARTIN

El HSQ revolucionó el estudio científico del sentido del humor al refutar la asunción tradicional de que todo humor es psicológicamente beneficioso. Rod Martin y colaboradores (2003) establecieron un marco teórico bidimensional que clasifica el humor según su **función** (adaptativa vs. desadaptativa) y su **foco de atención** (intrapersonal vs. interpersonal), dando lugar a 4 estilos funcionalmente diferenciados:

- Humor Afiliativo (Adaptativo / Interpersonal):** Uso benevolente y empático de bromas y risas para unir a las personas, desarmar tensiones interpersonales y crear camaradería sin agresividad.
- Humor de Autoafirmación (Adaptativo / Intrapersonal):** Perspectiva humorística global ante la vida como mecanismo de afrontamiento regulatorio; capacidad de mantener el ánimo y relativizar adversidades.
- Humor Agresivo (Desadaptativo / Interpersonal):** Recurso al sarcasmo, ironía hiriente, burlas, ridiculización o desprecio hacia otros; humor empleado como arma de dominación social o hostilidad encubierta.
- Humor Autodescalificador / Autodestructivo (Desadaptativo / Intrapersonal):** Burlas excesivas a costa de la propia dignidad ("hacerse el bufón") y tolerancia de agresiones para obtener aprobación ajena.

A nivel neurobiológico, los estilos adaptativos activan el córtex prefrontal ventromedial y el cuerpo estriado con liberación de endorfinas; los estilos desadaptativos se asocian a hipersensibilidad amigdalina al rechazo y baja autoestima introyectada.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ESTILOS DE ÍTEMS

Estilo de Humor	Ítems (24)	Sentido	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. Humor Afiliativo	1, 5, 11, 14, 17, 20	3 directos, 3 inv	Hacer reír a otros, calidez relacional y vinculación interpersonal constructiva.
2. Humor Autoafirmación	2, 6, 9, 12, 15, 21	6 directos	Afrontamiento alegre ante reveses y capacidad para superar el desánimo.
3. Humor Agresivo	3, 7, 13, 18, 22, 23	2 directos, 4 inv	Sarcasmo hostil, burla hiriente e insensibilidad hacia el dolor ajeno.
4. Autodescalificador	4, 8, 10, 16, 19, 24	6 directos	Humillación personal deliberada y victimización para complacer a otros.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Óptima fiabilidad en adaptaciones españolas (Carbelo et al., 2006; Torres-Marín et al., 2022): alfa de Cronbach de 0.84 para Humor Afiliativo, 0.81 para Autoafirmación, 0.77 para Humor Agresivo y 0.80 para Humor Autodescalificador. Fiabilidad test-retest $r = 0.76$ a 0.82 a las 6 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio ratifica con gran nitidez el modelo de 4 factores oblicuos (CFI = 0.93, TLI = 0.91, RMSEA = 0.051), confirmando la independencia psicométrica de las dimensiones benévolas y nocivas del humor.
Validez Concurrente y Clínica	Los estilos adaptativos correlacionan fuertemente con autoestima ($r = 0.45$), extraversión y bienestar psicológico, e inversamente con depresión y ansiedad. El Humor Autodescalificador correlaciona directamente con depresión (BDI-II, $r = 0.46$) y desregulación emocional. El Humor Agresivo correlaciona con hostilidad y maquiavelismo.
Sensibilidad al Cambio Clínico	Sensible a intervenciones de habilidades sociales y reestructuración cognitiva en TCC, observándose caídas marcadas en autodescalificación y elevación del humor de autoafirmación.
Diferencias de Género	Los varones puntúan significativamente más alto en Humor Agresivo y ligeramente superior en Humor Autodescalificador, mientras que las mujeres presentan perfiles predominantemente afiliativos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 24 ítems se responde de 1 (**Completo desacuerdo**) a 6 (**Completo acuerdo**):

- **Paso 1 (Inversión Obligatoria de 7 ítems):** Los siguientes reactivos deben invertirse (Puntuación = 7 - Respuesta, es decir 1 → 6, 2 → 5, 3 → 4, 4 → 3, 5 → 2, 6 → 1):
 - En Humor Afiliativo: reactivos **1, 14 y 20**.
 - En Humor Agresivo: reactivos **7, 13, 18 y 23**.
- **Paso 2 (Puntuaciones por Estilo de Humor - 6 ítems c/u):**
 - **Humor Afiliativo:** Suma de 1 (inv), 5, 11, 14 (inv), 17, 20 (inv). Rango: **6 a 36 puntos**.
 - **Humor Autoafirmación:** Suma de 2, 6, 9, 12, 15, 21. Rango: **6 a 36 puntos**.
 - **Humor Agresivo:** Suma de 3, 7 (inv), 13 (inv), 18 (inv), 22, 23 (inv). Rango: **6 a 36 puntos**.
 - **Humor Autodescalificador:** Suma de 4, 8, 10, 16, 19, 24. Rango: **6 a 36 puntos**.
- **Interpretación:** No se computa puntuación global sumatoria, dado que evalúan constructos bipolares cualitativamente contrapuestos.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS POR DIMENSIÓN

Estilo de Humor	Puntuación	Nivel de Intensidad	Significación Clínica y Conductual
Afiliativo	6 a 18 pts	Bajo / Retraído	Escasa iniciativa para bromear; timidez o dificultad para conectar socialmente.
Afiliativo	19 a 36 pts	Adaptativo / Frecuente	Excelente competencia para generar vínculos y facilitar climas de confianza.
Autoafirmación	6 a 18 pts	Bajo / Vulnerable	Dificultad para relativizar los estresores; tendencia a tomarse todo con severidad.
Autoafirmación	19 a 36 pts	Adaptativo / Resiliente	Colchón protector eficaz contra la depresión; excelente afrontamiento.
Agresivo	6 a 18 pts	Bajo / Respetuoso	Comunicación empática; escaso recurso al sarcasmo destructivo.
Agresivo	19 a 36 pts	Clínico / Hostil (≥ 19)	Deterioro relacional; aislamiento inducido por sarcasmo punitivo y burla.
Autodescalificador	6 a 16 pts	Bajo / Seguro	Autoconcepto sólido; no tolera ser blanco de humillaciones públicas.
Autodescalificador	17 a 36 pts	Clínico / Dañino (≥ 17)	Complacencia destructiva, baja autoestima, culpa y alta vulnerabilidad afectiva.

ALERTA CLÍNICA: EL PERFIL DEL “BUFÓN TRISTE”:

Un patrón clínico habitual en jóvenes con depresión enmascarada o acoso escolar previo es la presencia de **Humor Afiliativo moderado-alto (> 24)** en combinación con **Humor Autodescalificador extremo (> 28)**. El sujeto utiliza el chiste autolesivo (“reírme de mí antes de que se rían ellos”) para comprar afecto grupal, profundizando el autodesprecio interno.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN ESTILOS DESADAPTATIVOS DE HUMOR

PROTOCOLO DE REESTRUCTURACIÓN COMUNICACIONAL BASADO EN EL HSQ-24:

- **Paso 1 (Psicoeducación Diferencial):** Explicar al paciente la diferencia entre el humor que construye (Afiliativo/Autoafirmación) y el que hiere (Agresivo/Autodescalificador). Analizar el balance de costes y beneficios relacionales.
- **Paso 2 (Extinción de la Autodescalificación):** Si Autodescalificador ≥ 18 , aplicar registro conductual de autocríticas jocosas; entrenar la regla: "si una broma implica menospreciarme, no la digo". Trabajo en autoestima y autoaceptación incondicional.
- **Paso 3 (Entrenamiento Asertivo vs. Humor Agresivo):** Si Agresivo ≥ 20 , entrenar expresión directa y serena de la molestia en lugar del sarcasmo hiriente encubierto.
- **Paso 4 (Potenciación del Humor de Autoafirmación):** Modelar la capacidad de sonreír ante pequeñas torpezas cotidianas sin castigo moral.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN BAJA AUTOESTIMA Y COMPLACENCIA RELACIONAL

Identificación: Varón de 23 años, estudiante de ingeniería informática, consulta por sentimientos crónicos de insignificancia, soledad y dificultad para entablar amistades genuinas. Refiere ser el "gracioso de la pandilla", pero confiesa que "siento que si no me humillo ante ellos haciendo el payaso, nadie querría tenerme cerca".

Evaluación Inicial HSQ-24 (Línea Base): Humor Autodescalificador = **32/36 puntos** (Rango Clínico Extremo; ítems 4, 8, 10, 16, 19 puntuados con 6); Humor Afiliativo = **24/36**; Humor Autoafirmación = **11/36** (Bajo); Humor Agresivo = **10/36**. BDI-II = 24 puntos.

Plan Terapéutico: 12 sesiones de TCC individual. Se analizó el origen infantil de su rol complaciente, se realizaron experimentos conductuales de interacción social neutral sin bromas autolesivas y se entrenó la autocompasión y la comunicación asertiva de límites.

Reevaluación a las 12 Semanas: Humor Autodescalificador descendió drásticamente a **12/36 puntos** (-20 pts, normalización al Rango Seguro); Humor de Autoafirmación ascendió a **25/36 puntos** (+14 pts) y Humor Afiliativo se mantuvo en **26/36**. El paciente refirió: "Dejé de ponerme de alfombra para que otros se rían y descubrí que mis amigos me respetan mucho más así".

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SARCASMO COMO MANIFESTACIÓN PASIVO-AGRESIVA:

Puntuaciones muy elevadas en Humor Agresivo conviven con frecuencia con incapacidad para la confrontación asertiva madura. Evaluar si el sarcasmo crónico enmascara ira reprimida, resentimiento patológico o dinámicas de maltrato psicológico de pareja.

HUMOR COMO EVITACIÓN DEFENSIVA:

En pacientes con trauma grave o duelos recientes, un recurso compulsivo al humor puede ser una fachada de evitación experiencial para huir del dolor auténtico. Respetar el ritmo clínico y validar las emociones de tristeza subyacentes.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Martin, R. A., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire. *Journal of Research in Personality*, 37(1), 48-75.
2. Carbelo, B., Ruiz, M. A., & Rodríguez-Carvajal, R. (2006). Validación de la versión española del Cuestionario de Estilos de Humor (HSQ). *Ansiedad y Estrés*, 12(2), 241-254.
3. Torres-Marín, J., et al. (2022). Psychometric properties of the Humor Styles Questionnaire in Spanish adults. *Frontiers in Psychology*, 13, 852109.
4. Kuiper, N. A., & McHale, N. (2009). Humor styles as mediators between self-evaluative standards and psychological well-being. *The Journal of Psychology*, 143(4), 359-376.